

Les médicaments anti-infectieux : antiseptiques et odontologie en plus.

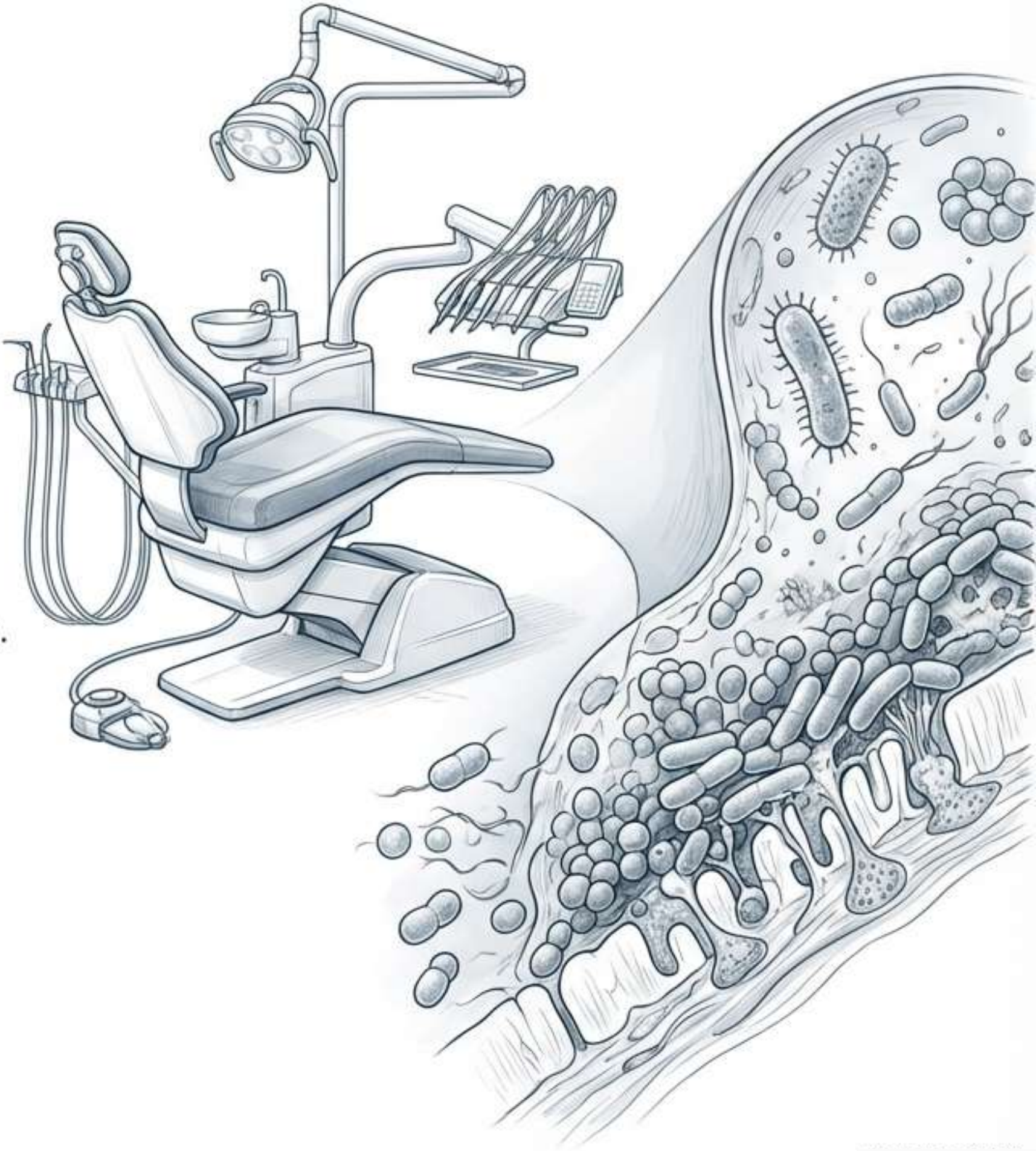
Guide de Maîtrise Académique et Pharmacologique.

Guide de Maîtrise Académique et Pharmacologique

Année Universitaire: 2025-2026.

Auteur: Dr ADDA ABBOU Leila (Pharmacienne spécialiste en pharmacologie).

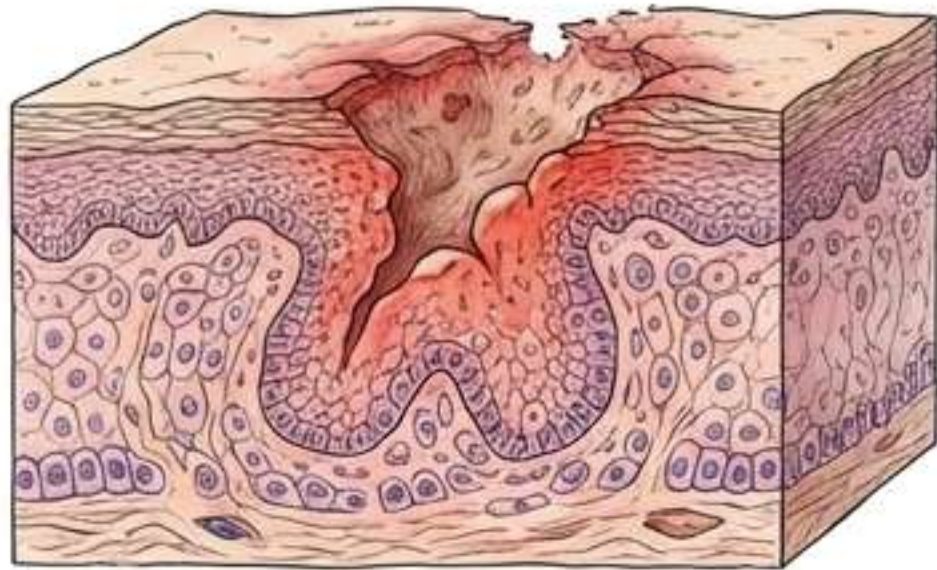
Audience: Cours pour 3^{ème} année médecine dentaire.



Plan du Cours Intégré	
1. Définition	6. Critères de choix
2. Mécanisme d'action	7. Principes d'utilisation
3. Résistance	8. Indications
4. Qualités idéales	9. Moyens d'utilisation
5. Facteurs d'influence	10. Catégories d'antiseptiques

Définitions Fondamentales & Différentiation

Antiseptique : Médicament (agent antimicrobien).
Application stricte sur peau ou muqueuse lésée.



Tissus Vivants / Muqueuse Lésée

L'utilisation thérapeutique doit être précise et limitée dans le temps. [Ref: Q15, Q19, Q4, N°2 (2017), N°13 (2016)]

Désinfectant : Concerne exclusivement les surfaces inertes (sols, dispositifs médicaux) et la peau saine (solutions biocides).



Surfaces Inertes / Peau Saine

Ils doivent être utilisés sur les tissus vivants (peau et les muqueuses) propres, en opposition aux milieux inertes. [Ref: Q15, Q19, N°4 (2019)]



Concept de l'Antisepsie : Opération au résultat momentané.

Action : Permet au niveau des tissus vivants *d'éliminer*, de *tuer* ou *d'inactiver* les micro-organismes.

Principes Généraux d'Utilisation & Incompatibilités



Surveillance Clinique

Il faut bien repérer les incompatibilités des différents produits et surveiller la tolérance locale. [Ref: Q15, Q19, Q4, N°13 (2016)]

Le prescripteur doit connaître les effets indésirables locaux ou plus rarement généraux.



Règle d'Exclusion Absolue

Ne jamais mélanger ou employer successivement deux antiseptiques différents. [Ref: Q15, Q19, Q4]

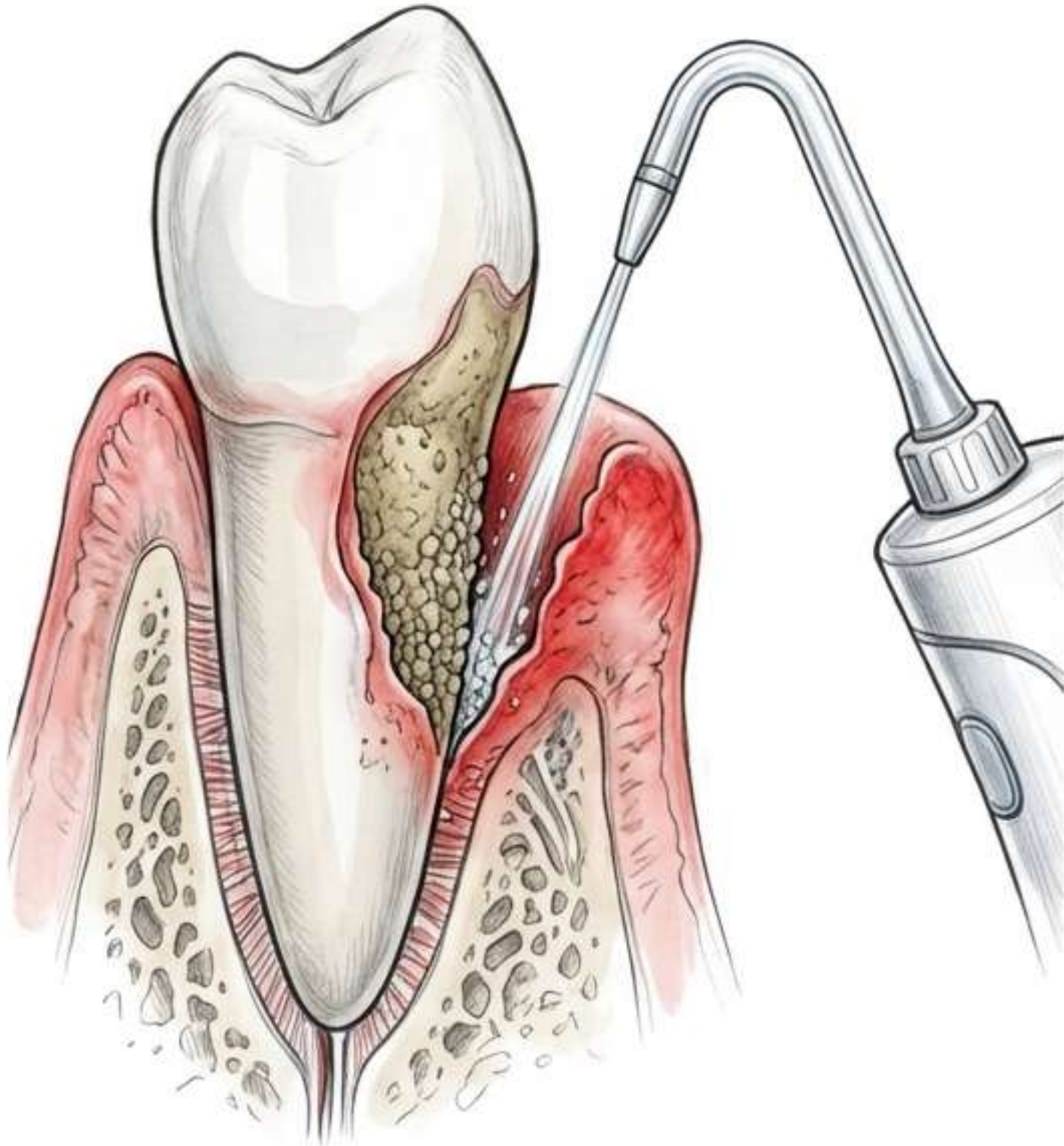
Risque majeur d'inactivation ou de toxicité.



Gestion du Produit

Respecter strictement les conditions de conservation et d'emploi des antiseptiques.

Pathologies et Indications Cliniques (Parodontologie)

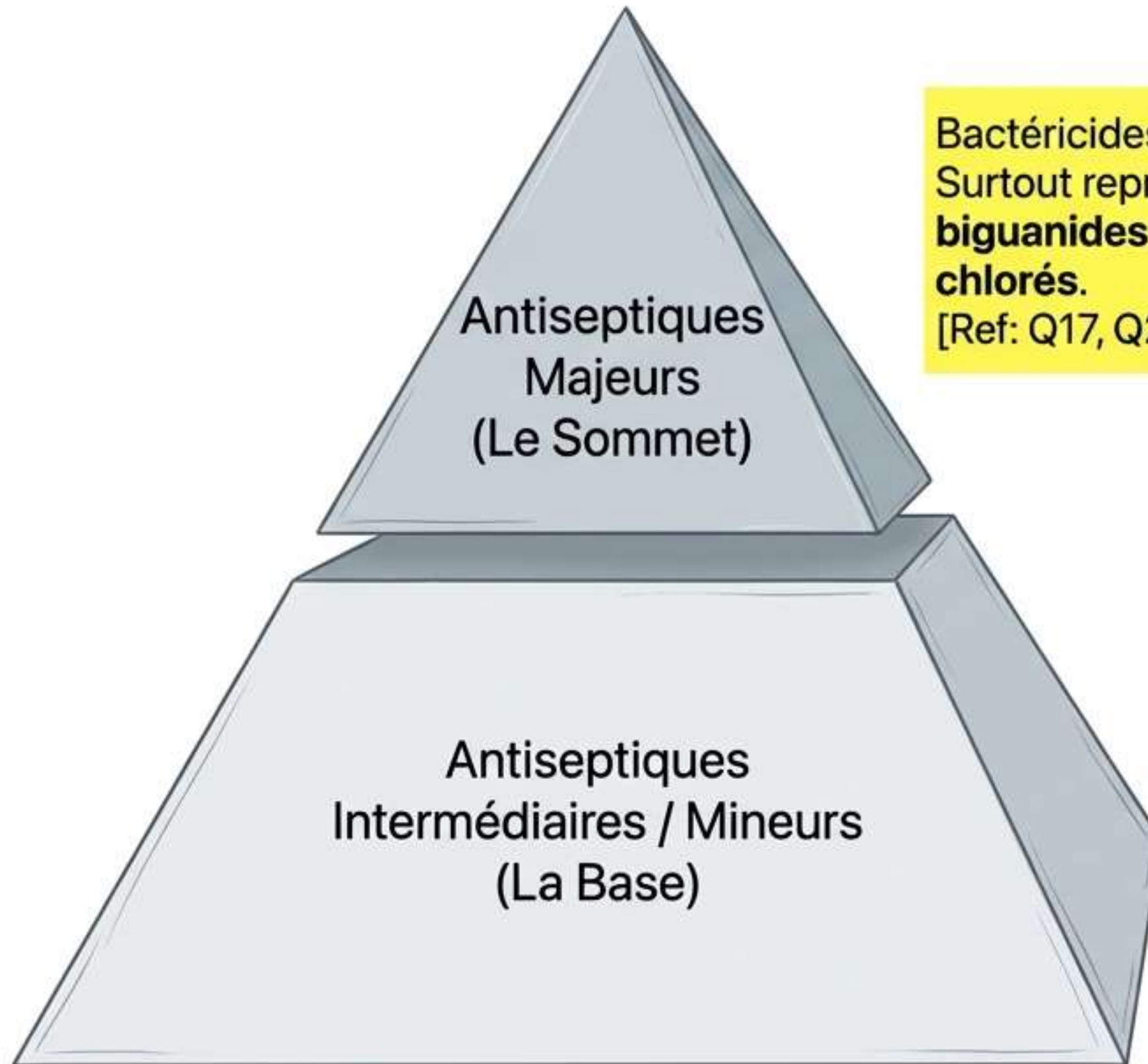


Motifs de Consultation : Pathologies parodontales, périapicales ou carieuses.
Rôle Stratégique : Agit comme substitut ou supplément aux méthodes mécaniques.

Les 7 Indications Majeures (Prévention et Traitement Actif)

1. Patients montrant une faible compliance à l'hygiène buccale (phase active ou soutien).
2. Personnes physiquement et mentalement handicapées.
3. Patients prédisposés aux infections orales (accent sur candidose orale et stomatite).
4. Patients portant des appareils orthodontiques amovibles et fixes.
5. Prévention secondaire post-opératoire (y compris chirurgie parodontale).
6. Patients hospitalisés à long terme et malades en phase terminale.
7. Chez les patients à risque oslérien pour limiter une bactériémie.
[Predicted - Application systémique d'un traitement local]

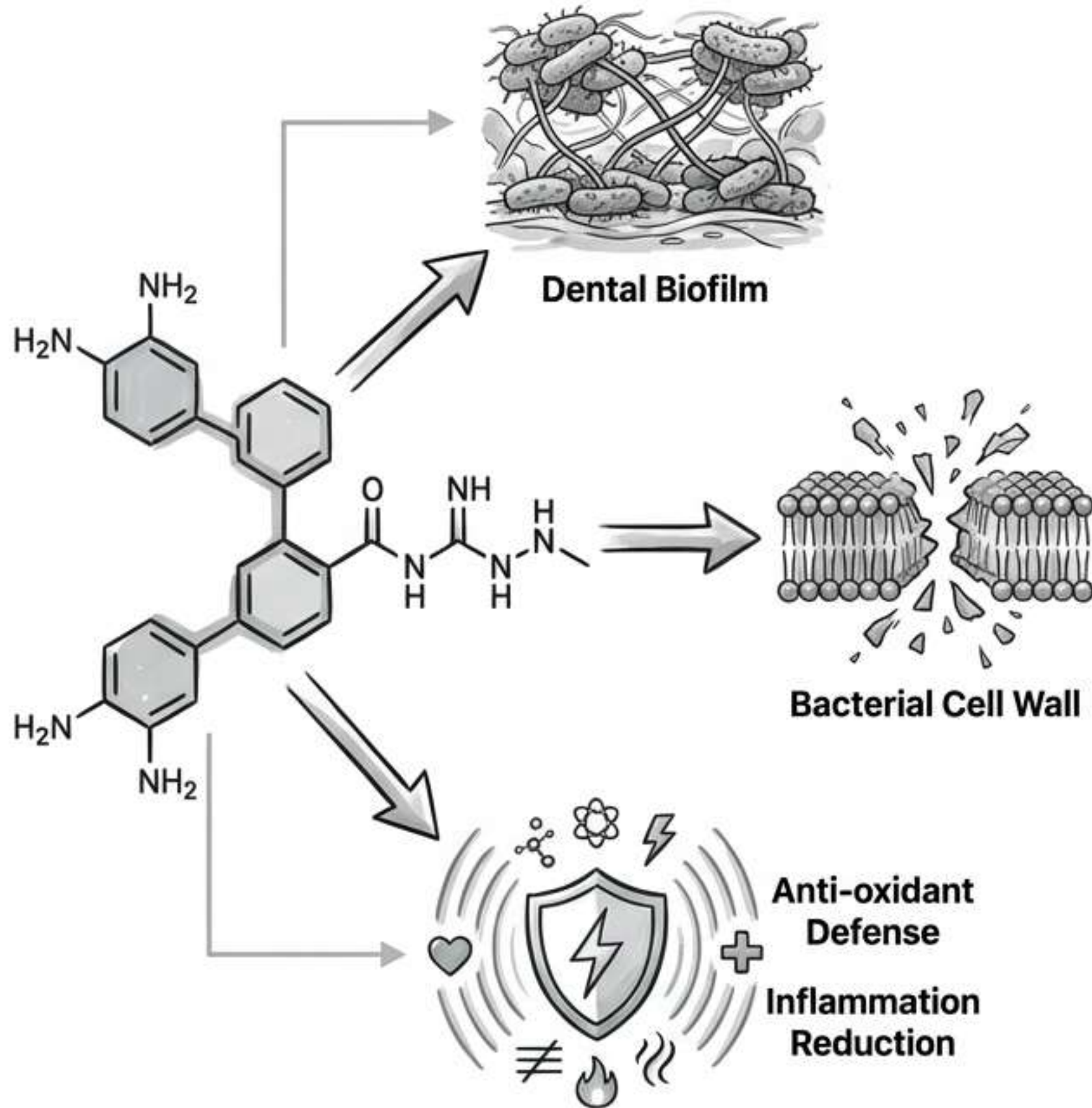
Classification Hiérarchique des Antiseptiques



Bactéricides à large spectre.
Surtout représentés par les **biguanides** et les **dérivés iodés** ou **chlorés**.
[Ref: Q17, Q20, N°1 (2017), N°15 (2016)]

Bactéricides à spectre étroit ou bactériostatiques/fongistatiques.
Familles : Ammoniums quaternaires, Phénols, Acides, Hexétidine.
Peuvent rendre des services, à condition de bien connaître leurs limites diagnostiques et pharmacologiques.

Antiseptiques Majeurs : Les Biguanides (Chlorhexidine) - Profil



Classification Officielle

Antiseptiques de Catégorie A : Agents antiseptiques antiplaque. [Ref: Q17, Q20, N°14 (2016)]

Propriétés Pharmacologiques

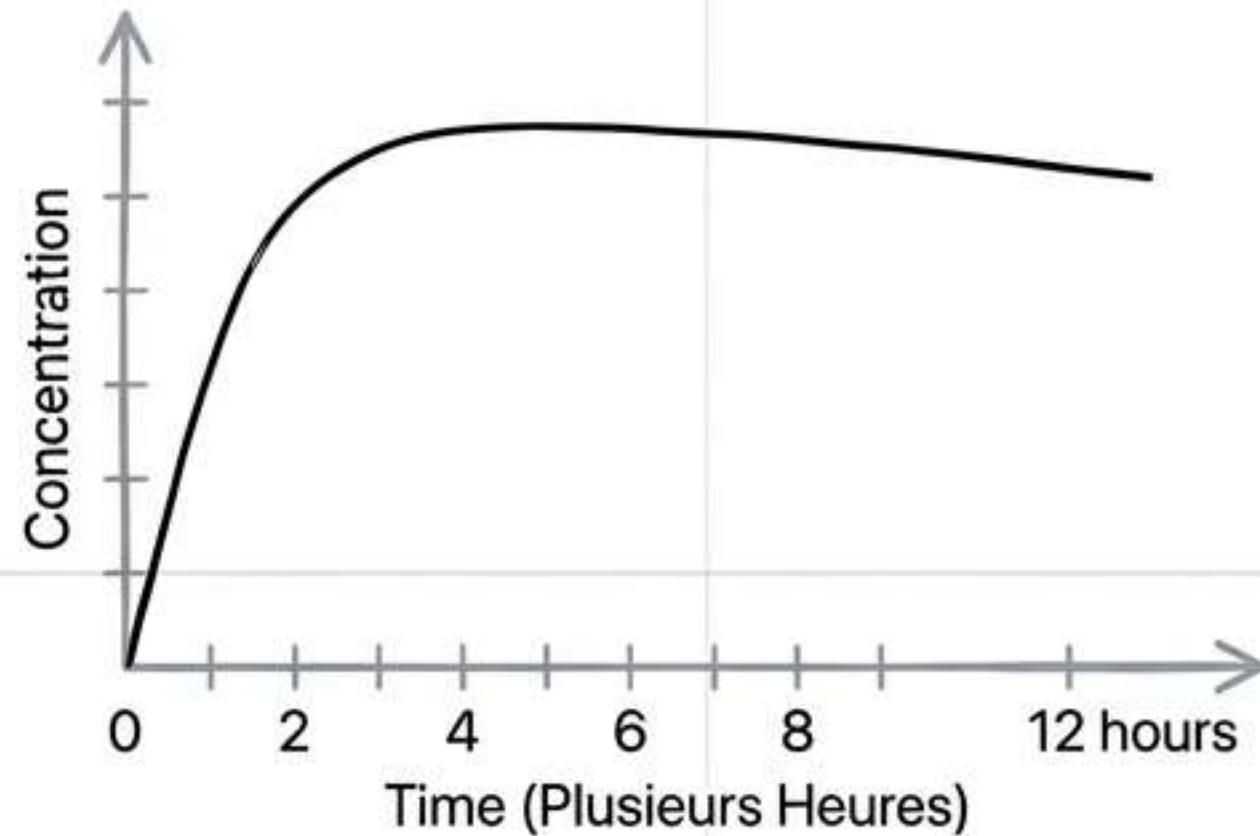
- **Bactéricides à large spectre.** [Ref: Q17, Q20, N°17 (2025)]
- **Inhibent la formation du biofilm** (diminue risque maladies parodontales et carieuses).
- **Action Anti-inflammatoire** : par son pouvoir détergent et antioxydant.
- **Effet Antifongique.**

Indication Spécifique

- Contrôle de la bactériémie chez les patients à risque d'endocardites.
- Remplacement de l'élimination mécanique après chirurgie.

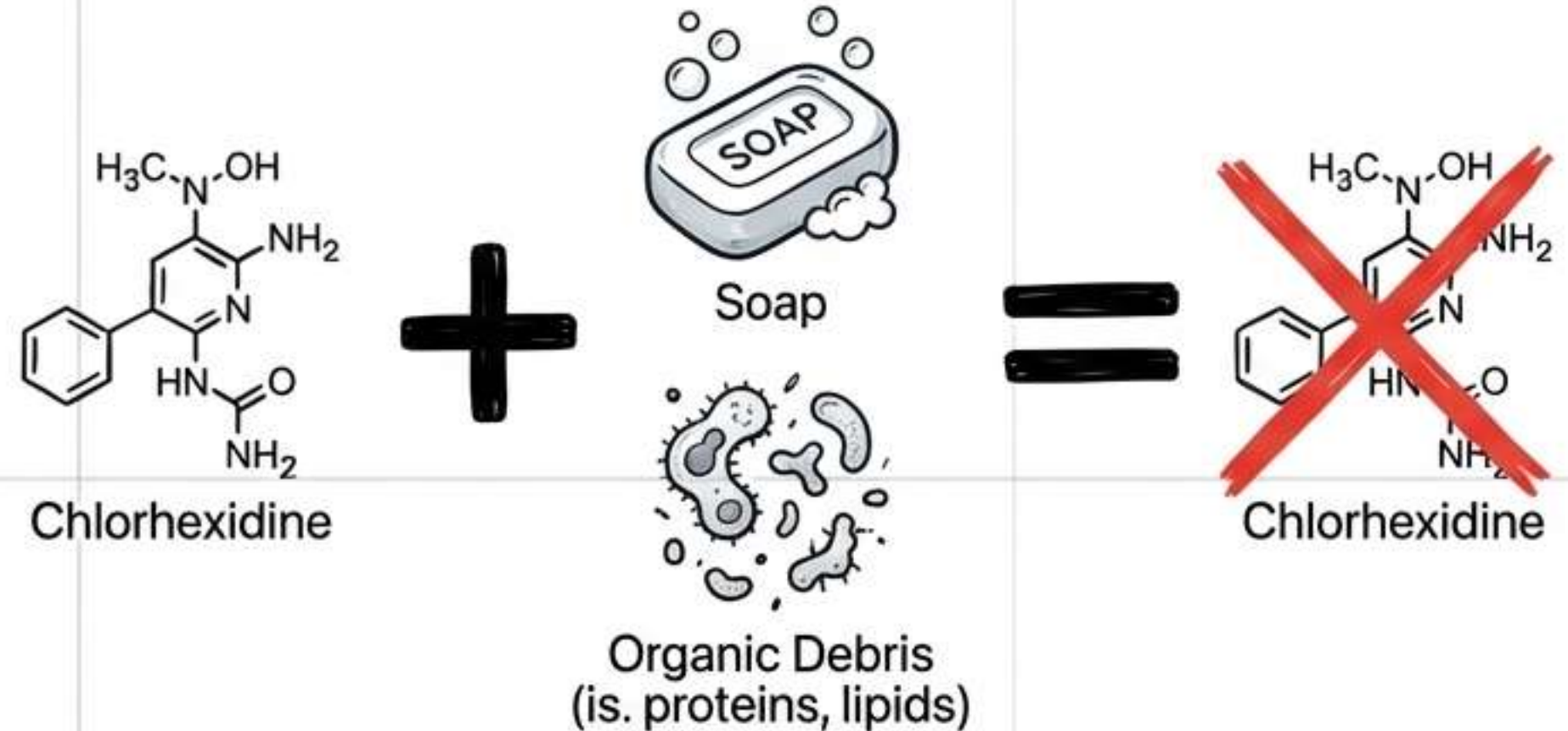
Antiseptiques Majeurs : Les Biguanides - Cinétique & Incompatibilités

Cinétique de Rémanence



Effet Rémanent (Cinétique) :
Active plusieurs heures après son passage dans la cavité buccale.

L'effet rémanent est dû à la capacité de rétention sur les surfaces buccales. [Predicted - Mécanisme biologique de la rémanence]



Inhibiteurs Strictes (Pièges d'Examen) :
Inactivés par : Les matières organiques et les savons.
[Ref: Q18]

Moyens d'Utilisation :

Administration sous forme de bain de bouche.
Irrigation sous-gingivale en complément du traitement mécanique.

Antiseptiques Majeurs : Les Dérivés Iodés (Halogénés)

Formulations Médicales :

Solutions aqueuses d'iode : à 1% (très peu utilisées).

Les iodophores : $\approx 10\%$ d'iode (ex: Betadine). Solution pour application locale ou bain de bouche.

[Predicted - Pourcentage exact de la Betadine]

Drapeaux Rouges & Contre-Indications Absolues



Antécédents ou exploration thyroïdienne.



Enfant de 1 mois à 30 mois : application brève, peu étendue, suivie d'un lavage à l'eau stérile. [Predicted - Fenêtre pédiatrique stricte]

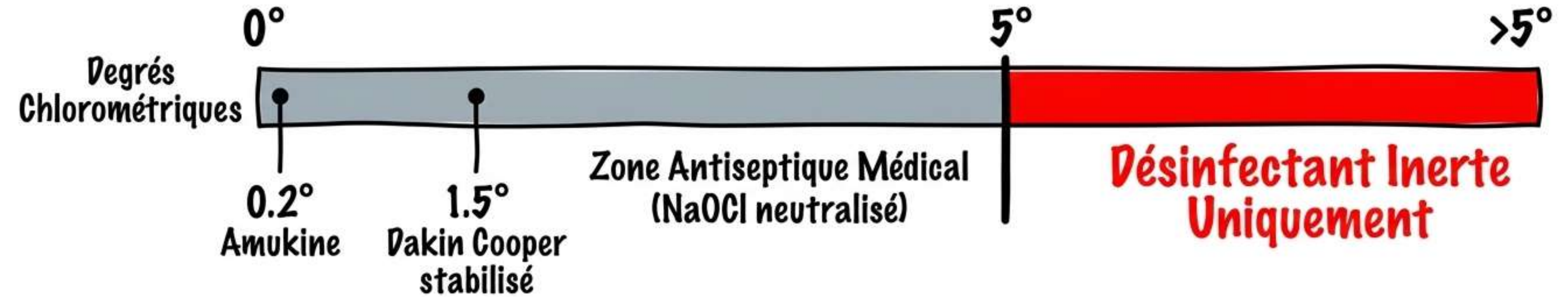


Grands brûlés : $> \text{à } 10\%$ de la surface corporelle (surcharge en iode = dysfonctionnement thyroïde). [Predicted - Seuil de toxicité cutanée]



Instabilité à la chaleur/lumière.
Corrosif avec des métaux.
Ne jamais mélanger avec des dérivés mercuriels (formation de composés caustiques).

Antiseptiques Majeurs : Les Dérivés Chlorés (Halogénés)



Spectre d'Activité :

Étendue : bactéries, champignons, virus, et Spores [Predicted - Seule mention spécifique d'action sporicide]

Seuils de Dilution (Hypochlorite de sodium - NaOCl) :

Eau de Javel diluée et neutralisée pour l'usage médical.

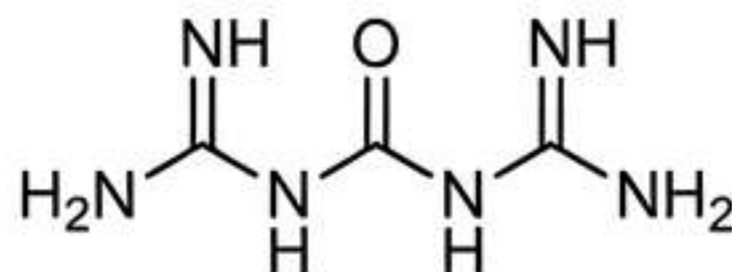
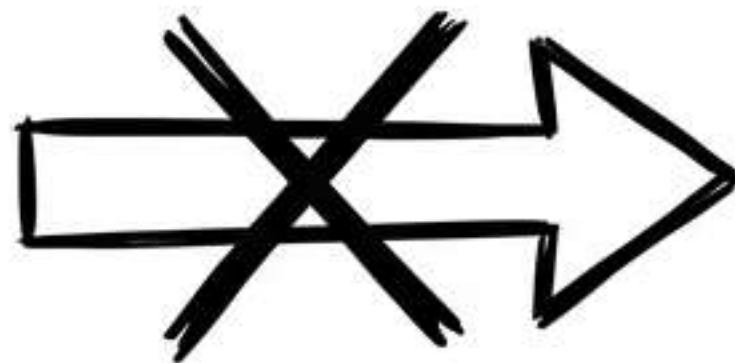
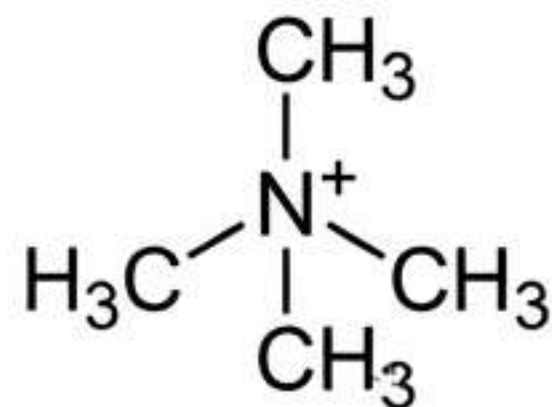
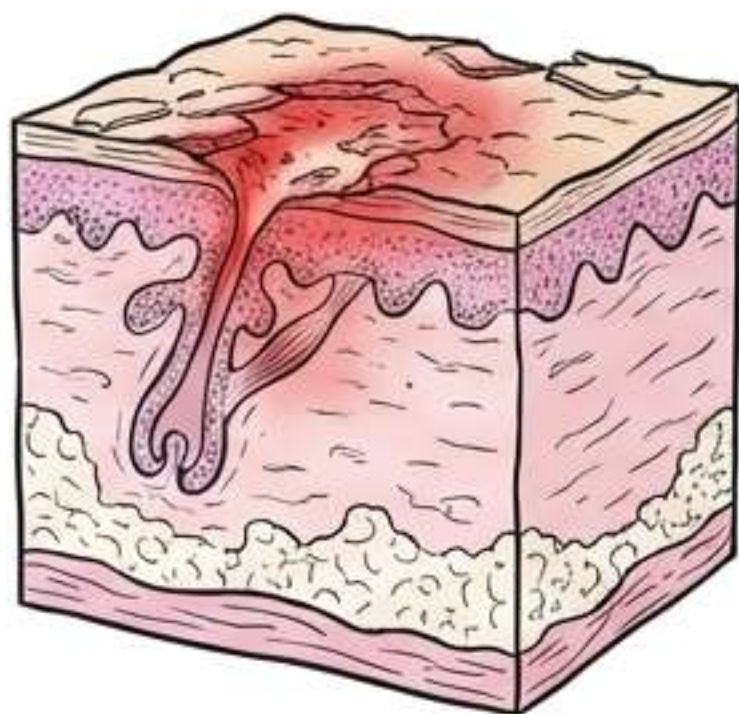
Limite stricte : Jusqu'à un titre de 5 degrés chlorométriques maximum. Au-delà = désinfectant. [Predicted - Frontière chimique Désinfectant/Antiseptique]

Spécialités et Conservation :

Officinal ou hospitalier : se conserve 3 semaines au maximum.

Spécialités à conservation prolongée : Amukine (0,2 degré) et Dakin Cooper stabilisé (1,5 degré). [Predicted - Valeurs exactes des spécialités]

Antiseptiques Intermédiaires : Ammoniums Quaternaires



1. Classification et Efficacité :

- **Catégorie B : Agents inhibiteurs de la plaque. Bactériostatiques et fongistatiques.** [Ref: Q16]
- Activité antiseptique globalement faible.
- **Ils ne présentent qu'un effet rémanent bref (ou aucun).** [Ref: Q16]

2. Règles d'Utilisation Stricte :

- **Conservation maximale des solutions aqueuses : 8 jours après ouverture** (se contaminent très facilement). [Ref: Q16]
- Faible concentration d'usage : 0,5 % à 5 %.

3. Effets Secondaires & Interactions :

- Causticité locale : érythème desquamatif cutané et érosions muqueuses.
- **Attention : Les Ammoniums Quaternaires ne sont PAS des inhibiteurs des Biguanides.** [Ref: Q18]

Antiseptiques Intermédiaires : Phénols & Acides



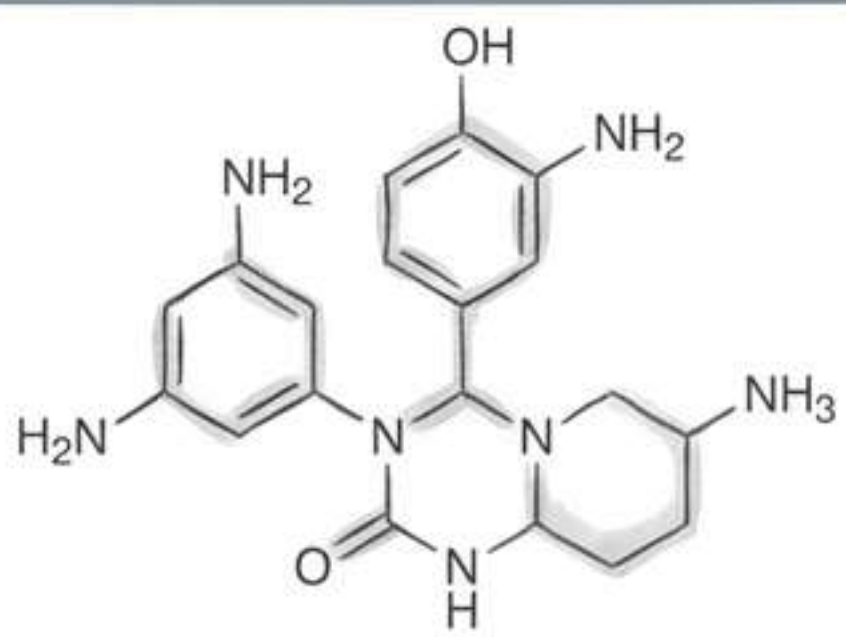
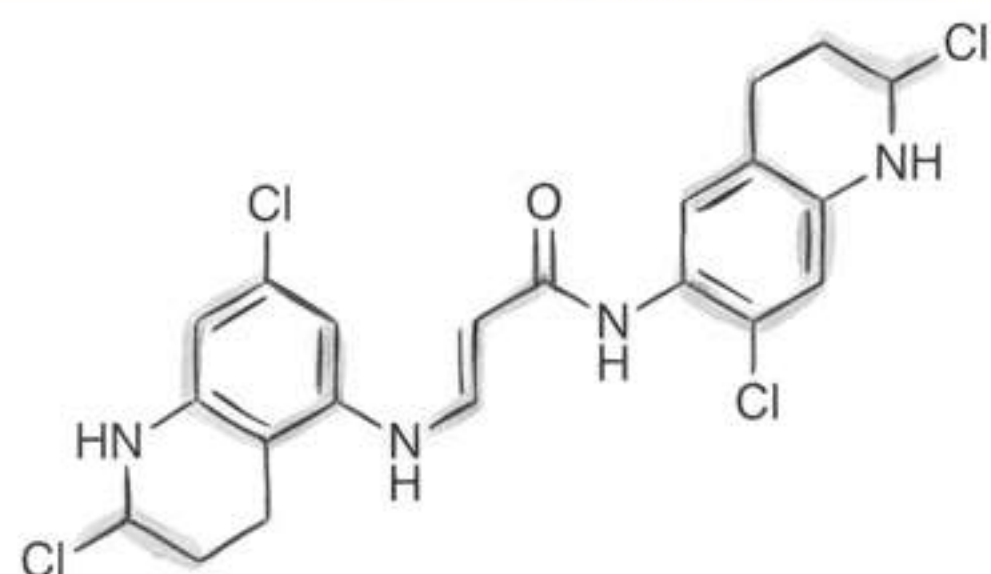
1. Les Phénols (ex: Listérine, Triclosan) :

- Composés d'huiles essentielles : menthol, thymol, eucalyptus et méthylsalicylate.
- Activité : Antibactérien large spectre, anti-inflammatoire, anti-plaque (Catégorie B).
- Posologie : Bain de bouche 2x/jour (prévention carie, gingivite, halitose, maintenance implantaire).
- Tolérance : Bonne, malgré sensation de brûlure et mauvais goût.
- Interactions : Nombreuses (sels de métaux lourds, agents tensioactifs non ioniques).

2. Les Acides :

- Acide borique (présent dans diverses spécialités).
- Acides organiques : acétique, benzoïque, lactique et tartrique.

Antiseptiques Intermédiaires : L'Hexétidine

Hexétidine	Chlorhexidine
	

Spécialités :

Seul : Hextril.

En association : Givalex (+ chlorobutanol et salicylate de choline).

Diagnostic Différentiel Pharmacologique (vs Chlorhexidine) :

Activité Globale : Au mieux égale($\leq$) à celle de la Chlorhexidine.

Effet Rémanent : NUL. Elle ne possède pas la capacité de rétention sur les surfaces buccales de la chlorhexidine.

[Predicted - Piège classique de comparaison]

Effet Anti-plaque : Strictement inférieur à celui de la Chlorhexidine.

Effets Indésirables Spécifiques :

Altération temporaire du goût. Engourdissement buccal.

Protocoles Spécifiques : Mycose Buccale (Candidose)

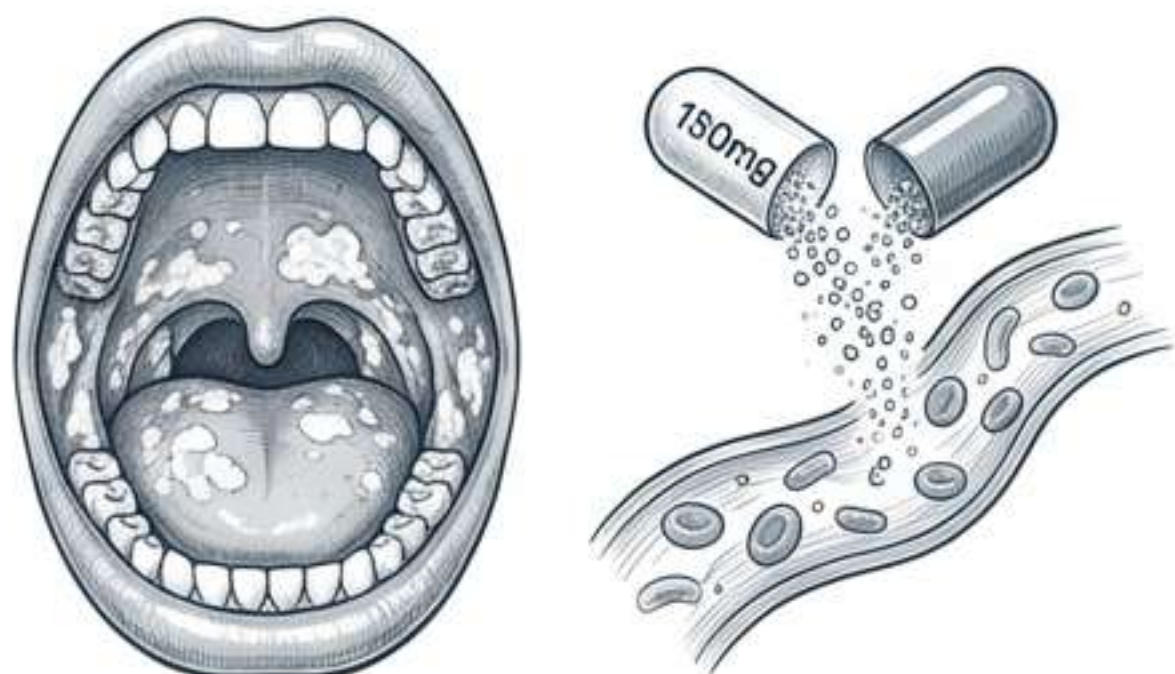
Top Pathway



Protocole Patient Porteur de Prothèse :

1. Nettoyer la prothèse, éviter de la porter la nuit. [Ref: N°13 (2022)]
2. Faire tremper dans une solution diluée d'eau de Javel ou de Chlorhexidine 0,12%. Bien rincer avant de porter. [Ref: N°13 (2022)]

Bottom Pathway



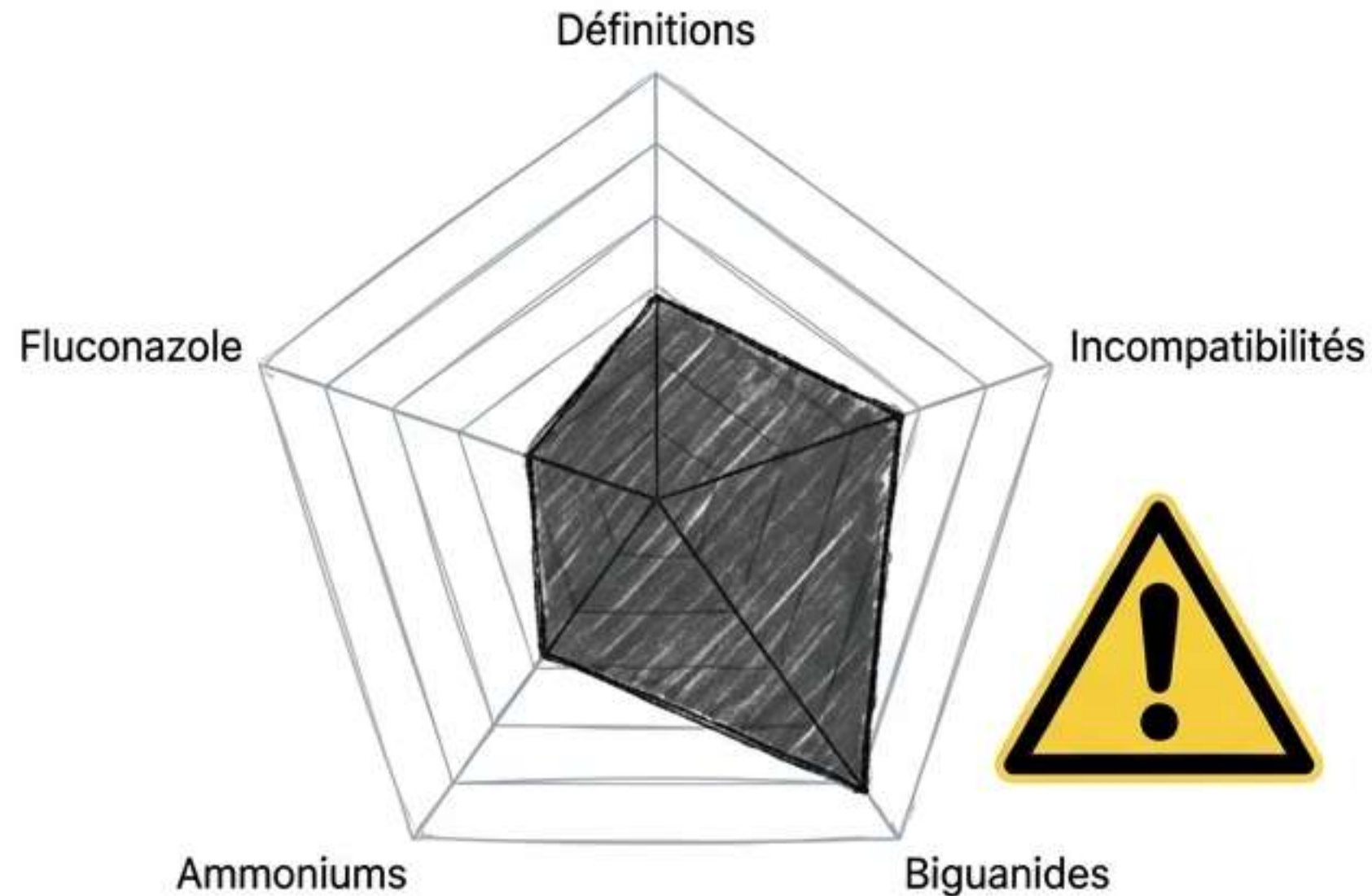
Protocole Patient Immunodéprimé (Lésions Étendues) :

Indication : Lésions muqueuses étendues, inaccessibles au traitement local (déficit immunitaire). Traitement systémique de 1^{ère} intention.

Molécule : Fluconazole (Triflucan) gélule 150 mg. [Ref: Q3]

Posologie : 50 à 100 mg par jour pendant 1 à 2 semaines.

Exam Pattern Analysis : Stratégie & Pièges Fréquents



Concepts les plus testés (Haute Probabilité) :

- **Distinction stricte Antiseptique** (tissus vivants) vs Désinfectant (inertes).
- Les **Incompatibilités** : Interdiction absolue de mélanger deux antiseptiques.
- **Chlorhexidine** : Catégorie A, Large spectre, inhibée par les savons.

Les Pièges Classiques :

- *Le Piège de Rémanence* : Seule la Chlorhexidine a une forte rétention. L'Hexétidine et les Ammoniums n'en ont pas/peu.
- *Le Piège de Conservation* : Les Ammoniums (Catégorie B) périssent en 8 jours max.
- *Le Piège de l'Inhibition* : Les Ammoniums NE neutralisent PAS les Biguanides.

Cibles Futures (Prédictions Vertes) :

Pourcentages exacts (lode >10% brûlure, Amukine 0.2°, Dakin 1.5°).

MIND MAP FINAL : Cartographie Globale des Anti-Infectieux

